

Información Paciente

Nombre : Sergio Marcelo Flores Farías

Rut : 12.866.014-3

N° Archivo : 0005936

N° Epicrisis

296670

Edad : 46a 8m 15d

Fecha Nacto: 27/06/1975

Sexo : Masculino

Dirección : Estacion Chihuayante ,Blok 0605, Depto 2

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 9 -84747763

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalización

Fecha Ingreso : 17/02/2022 01:06

Días Estadía: 25

Unidad de Egreso : Hospital De Campaña - Camas Básicas

Fecha Egreso : 14/03/2022 13:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Dolor torácico

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR: 17/02/22

FI UCI: 18/02/22

FI PAM: 04/03/22

FI HC: 08/03/22

Antecedentes:

- Mórbidos: HTA, obesidad.
- Quirúrgicos: (-).
- Fármacos: no adhiere a terapia anti HTA.
- Alergias: (-).
- Hábitos: TBQ 3 cigarrillos/día, OH ocasional, drogas (-)
- Hospitalizaciones recientes: (-)
- Inmunizaciones: 2 dosis COVID.
- Social: guardia de seguridad.

Anamnesis:

Paciente con antecedentes descritos, consulta por cuadro de 5 días de evolución de tos y cefalea, que evoluciona posteriormente con disnea progresiva, sin dolor torácico. Sin sintomatología gastrointestinal, anosmia o ageusia. Antecedente de contacto estrecho con paciente COVID (+), por lo que se realiza toma de PCR SARS CoV-2 que resulta positiva. En domicilio se pesquiza desaturación, motivo por el cual consulta en SU.

Ingresa en regulares condiciones generales, PA 118/75 (89), FC 115, T 36.4°C, sat 94% con 15 L por MAF. Evoluciona de forma tórpida, con marcado uso de musculatura accesoria y altos requerimientos de oxígeno, sin respuesta a CNAF por lo que se intuba el 17/02 y se inicia BNM. Se maneja con corticoides con protocolo Recovery y antibioterapia de primera línea de forma empírica. Posterior a sedación evoluciona hipotenso con requerimientos de DVA.

Ingresa a UCI para continuar manejo.

Exámenes de ingreso:

Hb 15, Hto 44, VCM 92, CHCM 33, GB 7320, RAN 6000, plq 162000, lactato 23, TTPA 42, INR 1.03, PCR 228, crea 1.22, BUN 23, ELP 135/5.01/98, GOT 57, GPT 32, FA 48, GGT 59, biliT 0.6, LDH 854, glucosa 111, alb 3.4, GSV pH 7.29, pCO2 55,

Fecha Epicrisis : 14/03/2022 13:18

Fecha Última Actualización: 14-03-2022 13:18:45

Página 2 de 3

HCO3 26, BE -1.5

Diagnósticos de ingreso:

- 1.-Neumonía grave por COVID 19
- 2.-Insuficiencia Respiratoria Aguda
- 3.-Antecedentes

Evolución durante hospitalización:

1. HDN: Con requerimientos de DVA en relación a sedación, posteriormente suspendidas. Evoluciona hipertenso, por lo que se indican VDO. Al alta con losartan y carvedilol en plan de titular requerimiento ambulatorio.
2. Respiratorio: Ingresa por COVID grave con requerimientos de VMI por 14 días con req de BNM y prono, extubado el 03/03 con weaning consolidado. Posteriormente se mantuvo con oxigenoterapia por naricera, evolucionando favorablemente con broncodilatación + KNT respiratoria. Logra suspender requerimientos de oxígeno 09/03, sin conflicto. Actualmente con buena mecánica ventilatoria, sin disnea, saturando adecuadamente. Sin desaturaciones al deambular asistido.
3. Infeccioso: Cursa con NAVM por SAMS, tratada con 7 días de ampicilina sulbactam y posteriormente cursa con NAVM por Klebsiella pneumoniae MS por lo que se prolongó tratamiento antibiótico. Completa 10 días de ampicilina/sulbactam, evolucionando nuevamente febril, por lo que se recultiva y se pesquisa Klebsiella ya conocida + E. coli resistente a dicho antibiótico por lo cual se rota a tazonom, iniciado el 01/03. EL 07/03 presenta peak febril por lo que se pancultiva; de momento SO levemente inflamatorio, UC negativo, HC de CVC y periféricos negativos la la fecha. sin nuevos peak febriles, por lo que se suspenden antibióticos. Ha evolucionado asintomático y con parámetros inflamatorio espontáneamente a la baja sin antibioterapia. No es conflicto actual.
- 4.Rehabilitación:
 - Motor: Movimiento activo asistido, buen control de tronco, bipedesta con moderada asistencia. Requiere KNT motora en domicilio.
 - FNA: Autorizado blando+ líquidos claros. Requiere terapia voz. Fonoaudiología para UHD.
 - Delirium: Requirió Precedex. Se mantuvo con antipsicóticos, dada evolución favorable de paciente se mantiene baja dosis nocturna con plan de suspensión en domicilio.
 - LPP: LPP glútea en curaciones por enfermería.

Últimos exámenes:

11/03: Hcto 36%, Hb 12.5, GB 4720, plaq 184.000, PCR 5.9, BUN 10, Crea 0.62, ELP 138/3.77/105
09/03: hb 11.7 GB 4.58 RAN 2500 PlaQ 192 142/3,9/108 Crea 0.64 BUN 11,4 PCR 11,7

Diagnósticos de alta:

- 1.Insuficiencia respiratoria aguda parcial resuelta
 - 1.1.NAC COVID19, antígeno COVID (+) 12/02; FIS 11/02, día +26
 - 1.2.IOT 17/02 - 03/02
 - 1.3.BNM 18/02 - 21/02
 - 1.4.Prono 18/02 -20/02
- 2.NAVM por Klebsiella pneumoniae MS + E. coli tratada
- 3.Disfagia del paciente crítico en rehabilitación
- 4.Miopatía del paciente crítico en rehabilitación
- 5.LPP glútea grado II en curaciones
- 6.Delirium hiperactivo resuelto
- 7.NAVM por SAMS tratada
- 8.Antecedentes: HTA, obesidad mórbida, tabaquismo activo, 2 dosis COVID19

Diagnóstico de Egreso

COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO - Neumonía Grave por COVID 19

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en BCG, HDNE, afebril, sin requerimientos de oxígeno. LPP sacra grado 2 en mejoría. Deambula con asistencia, autorizado régimen blando. Requerimientos de kinesioterapia motora, fonoaudiología (voz) y curaciones por enfermería de LPP grado II glútea.
Dr. Vásquez

Fecha Epicrisis : 14/03/2022 13:18

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 15:32

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Plan Post Alta

Reposo relativo asistido

Régimen blando+ líquidos claros (agua en sorbos cortos) PAUSADO, SENTADO 90°

Medicamentos:

- Bromuro de ipatropio 2 puff c/ 8 horas por AEC x 2 semanas, luego suspender.
- Carvedilol 12.5 mg cada 12 horas VO
- Losartán 50 mg cada 12 horas VO
- Risperidona 0.5 mg cada 24 horas PM por 14 días VO, luego suspender.

Hospitalización domiciliaria:

- Kinesioterapia motora y respiratoria
- Terapia fonoaudiológica
- Curaciones de LPP por enfermería

Controles:

- Control precoz en CESFAM para control de patologías crónicas y titulación de vasodilatadores orales.
- Derivación a programa nutricional de CESFAM
- Consultar en servicio de urgencias de presentar dificultad respiratoria, fiebre, decaimiento importante o según estime necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Ktm

Régimen Alimentario : Blando Hiposódico Hipocalórico

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Sofía Kutscher Campero
Médico Tratante (Staff)